

Valoración del riesgo de suicidio en urgencias

F. J. Montero Pérez, E. Ruiz Ruiz, P. J. Arévalo Frutos, J. A. Alcalá Partera y L. Jiménez Murillo

CONCEPTO

Existen tres principales alteraciones del comportamiento en torno al suicidio (tabla 71.1): el **pensamiento suicida**, la **comunicación suicida** (comunicación verbal o no verbal por medio de las cuales se transmite que existe deseo de morir) y la **conducta suicida**, en la que hay evidencia de que la persona desea utilizar la aparente intención de morir con alguna finalidad (conductas instrumentales), o presenta algún grado, determinado o no, de intención de acabar con su vida lográndolo o no (acto suicida).

El *riesgo de suicidio* (RS) es la posibilidad de que un paciente atente deliberadamente contra su vida o se autoleione gravemente poniendo en peligro su vida. Generalmente está asociado a personas con patología psiquiátrica o con enfermedad orgánica grave, frecuentemente degenerativa. En otros casos (5% aproximadamente) no están presentes ninguno de estos antecedentes, de manera que la persona tiene ideas suicidas de forma racional o consciente, denominándose así (*suicidio racional o consciente*) a este tipo de suicidio cuando la idea es definitivamente llevada a cabo.

El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España; produce 2,7 veces las provocadas por accidentes de tráfico, 13,6 veces más que los homicidios y casi 90 veces más que la violencia de género. Asimismo, el suicidio es, tras los tumores, la principal causa de muerte entre la juventud española (15-29 años). El grupo con mayor número de muertes por esta causa se produce entre los 40 y 59 años (41% del total). Por otra parte, el suicidio en personas mayores de 80 años ha aumentado un 20%, y en mujeres de 50 a 59 años ha aumentado un 27% respecto a 2019.

En el servicio de urgencias se atiende a pacientes con riesgo de suicidio; es un lugar donde se puede actuar de forma preventiva, si bien existen barreras para ello, como el alto volumen de pacientes atendidos, el carácter agudo de la mayor parte de procesos asistidos o la limitación de espacio, entre otras. La mayor parte de los pacientes que acaban culminando el suicidio han consultado en el año previo a su muerte en algún punto del sistema sanitario.

FACTORES PREDISPONENTES

El conocimiento de los factores predisponentes a la conducta suicida ayuda a la valoración de estos pacientes, aunque no sustituyen la exploración clínica.

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y PSICOSOCIALES

- Sexo: los hombres realizan con más frecuencia suicidios consumados que las mujeres, mientras que estas tienen tasas más altas de ideación e intentos.
- Edad: La prevalencia de suicidio consumado va aumentando desde la adolescencia y juventud hasta las últimas décadas de la vida, si bien en los últimos años ha aumentado entre los jóvenes, que en la actualidad también son considerados un grupo de alto riesgo.
- Raza: el 70% de los suicidios son cometidos por varones de raza blanca. La inmigración y el subsiguiente desarraigo, así como el aislamiento que comporta, aumenta el riesgo en este grupo poblacional.
- Estado civil: existe mayor frecuencia de suicidio entre divorciados y viudos, seguido por los solteros (con más tasas de intentos) que entre las personas casadas.
- Situación laboral: el desempleo, la inestabilidad y los conflictos laborales son más frecuentes entre quienes intentan el suicidio o lo consuman que en la población general.
- Medio rural o urbano: En el medio urbano existe una mayor prevalencia de intentos de suicidio, si bien la letalidad suele ser menor.

FACTORES MEDIOAMBIENTALES

- Antecedentes familiares de suicidio: incrementa el riesgo. El 5% de los suicidios tienen antecedentes de familiar muerto por suicidio.
- Estresores vitales: acontecimientos interpersonales, laborales, financieros o de otro tipo ocurridos en los últimos 3 meses aumentan el riesgo.
- Conducta suicida previa: es uno de los factores de riesgo más importantes, pues entre el 10-14% de las personas con tentativas de suicidio lo consuman.
- Fácil acceso a medios letales.

FACTORES CLÍNICOS

- Padecimiento de enfermedad crónica incapacitante: especialmente si conlleva dolor, pérdida de autonomía personal o modificación del estatus laboral.
- Diagnóstico psiquiátrico. El 90% de las personas que se suicidan padecen un trastorno psiquiátrico. Los más frecuentes son los trastornos afectivos (sobre todo depresión), alcoholismo y toxicomanía (más frecuentes

TABLA 71.1 Conceptos en torno al suicidio

Concepto	Tipo de alteración	Descripción
Pensamiento suicida	Ideas de muerte	Pensamientos acerca de morir
	Ideación autolítica	Pensamientos acerca de matarse o lesionarse
Comunicación suicida	Amenaza	Acto interpersonal, que podría predecir una posible conducta suicida en el futuro
	Plan suicida	Propuesta de un método con el cual realizar una conducta suicida
Conducta suicida	Autolesiones, gestos suicidas o parasuicidas	Conducta suicida en la que el paciente se autolesiona sin comprometer su vida (salvo en circunstancias no deseadas y que escapan a su autocontrol)
	Intento o tentativa de suicidio	Conducta suicida sin resultado fatal, pero en la que se buscaba la muerte
	Suicidio consumado	Muerte autoinfligida con evidencia, implícita o explícita, de que la persona deseaba morir

CUADRO 71.1 Signos y síntomas del riesgo suicida

Tentativas previas o fantasías de suicidio.
 Ansiedad, depresión, agotamiento.
 Disponibilidad de medios para suicidarse.
 Preocupación sobre los efectos del suicidio en los miembros de la familia.
 Verbalizaciones de la ideación suicida.
 Preparación de un testamento, resignación tras una depresión agitada.
 Crisis vital cercana, como un duelo o una intervención quirúrgica inminente.
 Antecedentes familiares de suicidio.
 Pesimismo o desesperanza generalizados.

en episodios de intoxicación, aunque también en los síndromes de abstinencia), trastornos de la personalidad y esquizofrenia.

- Trauma o abuso físico /psicológico o social.

En el [cuadro 71.1](#) se resumen los factores que incrementan el riesgo de suicidio, y en la [tabla 71.2](#), los factores de riesgo asociados al suicidio consumado y a la tentativa de suicidio.

Los trastornos depresivos constituyen la patología psiquiátrica que más frecuentemente origina suicidio, seguido de los trastornos derivados del uso de alcohol (entre ambos representan un 80% de las causas de suicidio). Aproximadamente un 10% de casos lo constituyen los trastornos neuróticos, la esquizofrenia, la dependencia de drogas y otros procesos psiquiátricos. Por último, las enfermedades orgánicas que causan dolor crónico intenso intratable, las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y el cáncer constituyen el restante 10%.

ACTITUD Y VALORACIÓN DIAGNÓSTICA

Existen una serie de aspectos importantes que se deben tener en cuenta en la valoración de estos pacientes:

TABLA 71.2 Factores de riesgo de la conducta suicida

Suicidio consumado (más frecuente en...)	Tentativa de suicidio (más frecuente en...)
Hombres	Mujeres
Mayores de 45 años	Menores de 35 años
Divorciado/viudo	Casada/soltera
Clase alta	Clase baja
Desempleado/jubilado	Ama de casa
Tentativas premeditadas	Tentativas impulsivas
Métodos violentos	Métodos de escasa repercusión letal
Depresión mayor, esquizofrenia, alcoholismo crónico	Depresiones menores, trastornos de la personalidad

- Es esencial hablar del suicidio para aliviar al individuo de la angustia de pensar en ello.
- El 80-90% de las personas que se suicidan habían hablado previamente de ello y el resto dejaron entrever sus intenciones.
- Los 90 días posteriores al intento son los más peligrosos. Tras la crisis puede haber apoyo social; posteriormente va decreciendo gradualmente, con lo que aumenta el riesgo de que aparezca conducta suicida.
- Los pacientes con enfermedad mental se suicidan con mayor frecuencia que la población general, pero no es necesario padecer un trastorno mental para suicidarse.
- En la mayoría de los actos suicidas hay ambivalencia respecto a la muerte. La persona desea morir si la vida continúa de la misma manera y desea vivir si se producen cambios en ella.

La situación más frecuente es la valoración de RS en un paciente que ha cometido un intento suicida fallido. En este caso lo primero es obviamente valorar y atender las

lesiones sufridas o las situaciones en las que el intento se ha realizado con tóxicos. Para ello pueden requerirse pruebas complementarias, como realizar una TC de cuello en casos de intento de ahorcamiento, un electrocardiograma en caso de intento de autólisis por antidepresivos tricíclicos. Posteriormente, cuando el paciente esté estabilizado, valorar la existencia de factores de riesgo de suicidio. El principal de ellos es la realización de un intento de suicidio previo, especialmente habiendo utilizado un método de gran violencia (ahorcamiento, precipitación, disparo por arma de fuego, etc.) o habiendo dejado una nota de despedida explicando el intento suicida realizado, o con lesiones físicas graves. En general, los intentos con menor probabilidad de supervivencia confieren mayor riesgo de suicidio y viceversa.

Otros factores que incrementan el RS son:

- Padecer algún trastorno psiquiátrico, incluyendo el alcoholismo.
- Estar o haber estado en tratamiento psiquiátrico.
- Ser varón, o mujer mayor de 60 años.
- Estar desempleado o jubilado.
- Vivir solo.
- Estar separado, viudo o divorciado.
- Tener problemas graves de salud física, especialmente dolor crónico intenso o enfermedad degenerativa.

Por otra parte, se ha de valorar el RS, aunque no se haya producido un intento de suicidio en el episodio que estamos asistiendo, en todo paciente que:

- Exprese *ideas de muerte* («ganas de acabar de una vez», «ganas de morirse», etc.).
- Manifieste ideas de suicidio, con especial atención si estas se imponen en el pensamiento del paciente, sin poder evitarlas.
- Se detecte abuso de drogas o alcohol.
- Diagnóstico de depresión, esquizofrenia o trastornos neuróticos.
- Adolescentes con problemas de conducta o alimentarios.
- Pérdida reciente de una relación afectiva.
- Sentimientos de desesperanza, baja autoestima, especialmente en pacientes con alguno de los factores anteriores.

Además de factores de riesgo existen **factores protectores**, como poseer habilidades positivas de afrontamiento y resolución de problemas, sentido de responsabilidad familiar (niños en el hogar), estar casado, creencias religiosas, soporte sociofamiliar adecuado, relación terapéutica positiva con el médico responsable, etc.

No existen factores de riesgo patognomónicos o combinación de factores de riesgo predictivos del suicidio, ni test específicamente validados para la prevención.

La estimación del riesgo de suicidio es un proceso complejo debido a la propia naturaleza de la conducta suicida y a las dificultades metodológicas que subyacen a su investigación. Así, actualmente no existen indicadores específicos de la conducta suicida o factores de riesgo con poder predictivo *per se*. Las dos herramientas básicas para la evaluación del riesgo de suicidio son la entrevista clínica y las escalas de evaluación, aunque estas no sustituyen al juicio clínico, sino que representan solo un apoyo o complemento.

ENTREVISTA CLÍNICA

A todo paciente psiquiátrico se le debe preguntar sobre ideas suicidas, evitando la tendencia a pensar por parte del médico de urgencias que ello puede inducirle a pensar sobre el suicidio. En este sentido se aconseja la realización en estos pacientes de un *screening* estructurado validado, frente al juicio personal o la utilización de un lenguaje difuso para interpretar pensamientos suicidas (v. https://www.joint-commission.org/-/media/tjc/documents/resources/patient-safety-topics/suicide-prevention/pages-from-suicide-prevention-compendium_5_11_20_updated-july2020_ep2.pdf).

Se debe hablar con el paciente a solas, en una habitación lo más aislada posible del entorno ruidoso, intentando conectar con el paciente estableciendo contacto visual, utilizando un lenguaje y tono que no denote juicio crítico. En ningún momento debe dejarse solo al paciente.

El tono del médico debe ser suave, mostrando empatía y respeto. Debemos conocer los antecedentes personales, somáticos y psiquiátricos del paciente, así como cambios recientes, y situación actual del enfermo.

El establecimiento de una pauta común de actuación optimiza el tiempo y la calidad del tratamiento, reduciendo a medio plazo el número de urgencias y eliminando riesgos potenciales para el paciente, sus allegados y el propio personal sanitario.

Durante la entrevista clínica se debe hacer una evaluación exhaustiva de los factores de riesgo y protectores previamente mencionados. Además, se deben valorar detenidamente las características del intento fallido:

- **Peligrosidad del método utilizado.** Los métodos violentos guardan una estrecha relación con la intencionalidad letal. Habitualmente se considera como violentos los intentos suicidas por precipitación, atropello, ahorcamiento, apuñalamiento o disparo con arma de fuego.
- **Conciencia de la efectividad de la tentativa.** Especialmente útil en el caso de las tentativas de suicidio por intoxicación. Debe evaluarse el grado de asombro que producen en el paciente las consecuencias de su ingestión.
- **Grado de planificación.** La ausencia de factores desencadenantes, así como la existencia de notas de despedida, realización de testamentos o seguros de vida, orientan hacia la existencia de una premeditación en el acto.
- **Accesibilidad/rescatabilidad.** Debe tenerse en cuenta si en la tentativa de suicidio se llevan a cabo maniobras para mantener la privacidad del acto o evitar el rescate.
- **Finalidad.** En ocasiones, la conducta suicida, está lejos de tener una finalidad letal, busca comunicar un malestar o provocar un cambio en las circunstancias del paciente.
- **Actitud ante el resultado.** Una vez estabilizado el paciente, debe explorarse la existencia de sentimientos de alivio ante la salvación o si, por el contrario, surgen sentimientos de frustración por el fracaso de la conducta suicida.

En el **cuadro 71.2** se muestran algunas claves de la entrevista clínica ante el paciente con conducta suicida.

CUADRO 71.2 Algunas claves de la entrevista clínica ante el paciente con conducta suicida**¿EN QUÉ MOMENTO PREGUNTAR?**

Crear previamente un ambiente tranquilo y empático, para que la persona se sienta comprendida.
 Cuando el paciente se sienta cómodo expresando sus emociones, sentimientos, preocupaciones, etc.
 Cuando el paciente está en proceso de expresar sentimientos negativos de soledad o impotencia.

¿QUÉ PREGUNTAR?**Sobre el plan suicida**

¿Tiene planes para acabar con su vida? ¿Tiene pensado cómo lo haría?

Sobre el método utilizado

¿Tiene pastillas, algún arma, insecticidas o algo similar? ¿Ha buscado información sobre ello?

Para intentar averiguar si se ha fijado en llevar a cabo el suicidio próximamente

¿Ha pensado cuándo va a llevar a cabo el plan de acabar con su vida? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Hay algo que le frene para no hacerlo?

¿CÓMO PREGUNTAR?

¿Cómo se siente? ¿Ha pensado alguna vez en hacerse daño? ¿Se siente desesperado?

¿Piensa que la vida no merece la pena? ¿Quiere acabar con su vida?

¿Se ha planteado la muerte como solución a su problema? ¿Se siente incapaz de enfrentar el día a día?

Un caso frecuente es el paciente con RS que está bajo los efectos de alcohol y drogas. Estos pacientes, una vez ceden los efectos tóxicos puede cambiar su actitud suicida.

Por otra parte, existen fármacos que pueden incrementar el riesgo de suicidio, sobre todo en niños adolescentes y jóvenes menores de 24 años. Así, se ha descrito con los fármacos antitabaco vareniciclina y bupropión, los inhibidores de la recaptación de la serotonina (fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, fluvoxamina), otros antidepresivos como la venlafaxina, la mirtazapina o el nefazodone. Con ciertos antiepilépticos como carbamazepina, felbamato, gabapentina, lamotrigina o levetiracetam.

Se debe valorar el estado emocional, el contenido de pensamiento y afectos.

EXPLORACIÓN FÍSICA

- Realizar una exploración física sistemática en busca de lesiones en caso de intento fallido de suicidio.
- Buscar signos de intoxicación aguda (véanse los principales tóxicos en el capítulo 130) o de abstinencia.

ESCALAS PREDICTIVAS DEL RIESGO DE SUICIDIO

Aunque existen escalas para valorar el riesgo de suicidio (consultar https://www.jointcommission.org/-/media/tjc/documents/resources/patient-safety-topics/suicide-prevention/pages-from-suicide-prevention-compendium_5_11_20_updated-july2020_ep3_4.pdf), se considera que no pueden

TABLA 71.3 Escala SAD PERSONS modificada para la valoración del riesgo de suicidio

Ítem inglés (español)	Puntuación
Sex male (sexo masculino)	1
Age (edad) < 19 o > 45 años	1
Depression or hopelessness (depresión o desesperación)	2
Previous suicidal attempts or psychiatric care (intentos de suicidio o atención psiquiátrica previos)	1
Excessive alcohol or drug use (abuso de alcohol o drogas)	1
Rational thinking loss (trastornos cognitivos)	2
Separated, divorced or widowed (separado, divorciado o viudo)	1
Organized or serious attempt (plan organizado o serio de suicidio)	2
No social supports (sin apoyo social)	1
Stated future intent (intención futura de suicidio)	2
Puntuación total: Si < 6 puntos, se ha de valorar el apoyo sociofamiliar del paciente. Podría ser dado de alta (en función de las circunstancias) y realizar seguimiento médico estrecho. Si = 6-8 puntos, probablemente requiere consulta psiquiátrica. Si > 8 puntos, existe elevado riesgo suicida y se debe proceder a la hospitalización del enfermo. Nunca se debe considerar el resultado de una escala de puntuación de riesgo de suicidio como único criterio de decisión.	

utilizarse por sí mismas para tomar una decisión; en todo caso serán complementarias del juicio clínico.

Entre las diversas escalas de evaluación del riesgo de suicidio, la **escala SAD PERSONS modificada** (tabla 71.3) es probablemente la más conocida y utilizada en urgencias. Esta escala tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 60% para predecir el ingreso hospitalario.

EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA

Aquellos pacientes con un riesgo alto de suicidio y con escaso apoyo sociofamiliar deben ser valorados por psiquiatría de forma urgente, para manejo de patología psiquiátrica concomitante, y valorar la posibilidad de ingreso hospitalario como medida de contención a dichas conductas.

CRITERIOS DE INGRESO

La necesidad de ingreso hospitalario vendrá motivada por la existencia de un elevado RS, existencia de lesiones o intoxicaciones agudas asociadas que lo justifiquen.

Cuando el riesgo de suicidio es bajo o moderado y hay presente buen apoyo familiar, se debe optar por manejo

ambulatorio y seguimiento en unidad de salud mental. Constituyen indicaciones de tratamiento ambulatorio:

- No existencia de plan suicida concreto.
- No presencia de enfermedad psiquiátrica relevante.
- Bajo nivel de ansiedad.
- Apoyo familiar y social adecuado.
- Compromiso de «no suicidio» y de «sí a la vida».
- Aceptación por el paciente de tratamiento ambulatorio.

ACTITUD TERAPÉUTICA

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El tratamiento farmacológico recomendado deberá incluir tanto el de la patología psiquiátrica subyacente como de aquellos síntomas que puedan actuar como factores de riesgo adicional (ansiedad, insomnio, impulsividad, etc.).

MEDIDAS GENERALES

En los casos de seguimiento ambulatorio se debe:

- Tomar medidas para mejorar la seguridad del paciente al nivel óptimo posible.
- Diagnosticar y tratar los trastornos mentales subyacentes (prácticamente el 90% de los pacientes con conducta suicida presentan alguna enfermedad psiquiátrica).
- Valorar la medicación que se indica. Se debe recomendar el control familiar de ella, si es posible, y recurrir a los antidepresivos de riesgo letal mínimo.

Bibliografía recomendada

- Boudreaux ED, Larkin C, Camargo CA Jr, et al. Validation of a secondary screener for suicide risk: Results from the Emergency Department Safety Assessment and Follow-up Evaluation (ED-SAFE). *Jt Comm J Qual Patient Saf* 2020;46(6):342-52.
- Cochrane-Brink KA, Lofchy JS, Sakinofsky I. Clinical rating scales in suicide risk assessment. *Gen Hosp Psychiatry* 2000;22:445-51.
- Coshall S, Saunders J, Matorin AA, et al. Evaluation of Depression and Suicidal Patients in the Emergency Room. *Psychiatr Clin North Am* 2017;40:363-77.
- Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (avalia-t); 2012. Guías de Práctica Clínica en el SNS: Avalia-t 2010/02. (Consultado el 3 de enero de 2022.) Disponible en: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2020/09/gpc_481_conducta_suicida_avaliat_resum_modif_2020_2.pdf.
- Jacobs DG, Klein-Benheit M. Current Status of Suicide-Focused Assessment and Treatment. An Online Resource for Clinicians. (Consultado el 8 de febrero de 2022.) Disponible en: <https://www.mcleanhospital.org/sites/default/files/2021-08/Edu-Current-Status-of-Suicide-Focused-Assessment-and-Treatment-8-1-21-Final.pdf>.
- Lanuzzi GL, Ruth LJ, Wagoner RC, et al. Suicidio. En: Lipson Glick R, Zeller SL, Berlin JS, coordinadores. *Urgencias psiquiátricas. Principios y prácticas*, 2.ª ed. Barcelona: Wolters Kluwers; 2021. p. 323-31.
- Mullinax S, Chalmers CE, Brennan J, Vilke GM, Nordstrom K, Wilson MP. Suicide screening scales may not adequately predict disposition of suicidal patients from the emergency department. *Am J Emerg Med* 2018;36:1779-83.
- The Joint Commission Suicide prevention portal. (Consultado el 8 de febrero de 2022.) Disponible en: <https://www.jointcommission.org/resources/patient-safety-topics/suicide-prevention/>.

URGENCIAS ENDOCRINOMETABÓLICAS

CAPÍTULOS

72. Bases diagnóstico-terapéuticas de la diabetes mellitus	508
73. Manejo del paciente con diabetes hospitalizado	518
74. Diabetes mellitus en situaciones especiales. Hiperglucemia aislada	523
75. Hipoglucemia	528
76. Descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica	531
77. Cetoacidosis diabética	535
78. Apoplejía hipofisaria	539
79. Crisis mixedematosa	543
80. Crisis tirotóxica	547
81. Crisis addisoniana	553
82. Alteraciones del equilibrio acidobásico	557
83. Depleción hidrosalina	562
84. Hiponatremia	564
85. Hipernatremia	569
86. Hipopotasemia	573
87. Hiperpotasemia	576
88. Hipomagnesemia	579
89. Hiper magnesemia	581
90. Hipocalcemia	583
91. Hiper calcemia	586
92. Hipofosfatemia	589
93. Hiperfosfatemia	593